ALLEGATO TECNICO A AL CODICE 16 — PROTOCOLLO DI AVVIO SOCIALE

Versione: V1.3

Allegato tecnico adottato ai sensi dell’articolo 19 del Codice 3 e richiamato dagli articoli 1, comma 2, lettera h), 4 e 7, comma 5, del Codice 16.

Art. 1 — Natura, funzione ed effetti

1. Il presente Protocollo definisce una metodologia per valutare i passaggi sociali connessi all’avvio dei Cerchi pilota, dei Bacini e della Federazione minima. La metodologia è impiegata per verificare le soglie sociali istituzionali previste dall’articolo 4 del Codice 16.
2. Il Protocollo non costituisce fonte autonoma di obblighi, sanzioni, esclusioni o limitazioni individuali. La sua mancata applicazione:
   a) non costituisce, di per sé, una violazione ai sensi del Codice 4;
   b) non comporta sospensioni, sanzioni o pregiudizi individuali;
   c) non limita l’accesso al Codice 4, alla Garanzia, ai beni vitali o al Paniere 1-2.
3. La mancata applicazione documentata da parte del Cerchio può determinare esclusivamente il mancato superamento della soglia sociale istituzionale pertinente e, di conseguenza, impedire la proposta o la deliberazione del passaggio di fase. Tale effetto riguarda il Cerchio quale soggetto istituzionale e non produce conseguenze individuali.
4. Ai fini del presente Protocollo, il Consiglio di riferimento per la cura è:
   a) il Consiglio Salute, fino all’attivazione del Consiglio Cura;
   b) il Consiglio Cura, dall’attivazione prevista dal Codice 16, articolo 3, comma 3.
   Ogni riferimento al Consiglio di riferimento per la cura si intende effettuato secondo il presente comma.
5. La documentazione è prodotta, per quanto possibile, in forma aggregata e non profilante, secondo il Codice 7, articolo 2.2. I dati sono raccolti soltanto nella misura necessaria alla verifica della soglia pertinente. La soglia minima di aggregazione è definita dal Consiglio Rete quando attivo, per ridurre il rischio di identificazione diretta o indiretta, nel rispetto della separazione dei domini prevista dal Codice 6, articolo 11.
6. Il Protocollo non sostituisce le competenze, le procedure o le garanzie previste dagli altri Codici e non autorizza il Consiglio Transizione o altri organi ad adottare misure individuali non previste dalle norme applicabili.

Art. 2 — Livello 1: fiducia e avvio del Cerchio

Fase istituzionale di riferimento: Fase 0 del Codice 16, indicativamente da zero a sei mesi.
Durata operativa minima: da zero a novanta giorni.

1. Il Livello 1 mira a verificare la sostenibilità sociale iniziale del Cerchio pilota e a favorire condizioni minime di fiducia e collaborazione.
2. Prima della deliberazione costitutiva del Cerchio pilota sono organizzati tre incontri non deliberativi. Ogni partecipante può descrivere le proprie motivazioni, la disponibilità effettiva, i limiti personali e gli eventuali carichi di cura rilevanti per l’organizzazione. Le informazioni raccolte sono verbalizzate in forma aggregata e non nominativa.
3. È predisposta una mappa aggregata della capacità di cura e organizzazione, che può considerare:
   a) il tempo complessivamente disponibile per le attività del Cerchio;

b) la presenza di carichi di cura che incidano sull’organizzazione;

c) i bisogni funzionali rilevanti per predisporre attività accessibili;

d) gli indicatori organizzativi di sovraccarico.

La raccolta non costituisce diagnosi, valutazione sanitaria individuale o classificazione delle persone. I dati sono aggregati e non profilanti, conservati per non più di dodici mesi salvo diverso termine imposto da norma superiore e accessibili esclusivamente ai Consigli competenti per le finalità previste dal Protocollo.

4. Il Cerchio adotta un patto organizzativo che escluda l’impiego di minori, persone fragili o animali domestici di prossimità per colmare carenze organizzative, coprire turni incompatibili con la loro tutela o sostituire personale necessario.

5. Può essere previsto un momento simbolico e facoltativo di adesione al Cerchio pilota. Tale momento non produce effetti giuridici e non costituisce requisito per l’adesione, per l’accesso ai diritti o per la fruizione dei servizi essenziali.

6. Il Consiglio Transizione redige un’attestazione tecnica sull’applicazione del Livello 1 e sulla sostenibilità sociale risultante dai dati aggregati. L’attestazione contribuisce alla verifica della soglia F0 → F1 prevista dal Codice 16, articolo 4, comma 1, lettera d).

Art. 3 — Livello 2: convivenza e prevenzione del sovraccarico

Fase istituzionale di riferimento: Fase 1 del Codice 16, indicativamente da sei a diciotto mesi.
Durata operativa minima: da novanta a centottanta giorni.

1. Il Livello 2 mira a migliorare la convivenza operativa e a prevenire il sovraccarico dell’organizzazione e delle persone.

2. È offerta gratuitamente una formazione L1 sociale della durata complessiva di quattro ore, relativa almeno a:

   a) interruzione sicura delle attività rischiose;

   b) riconoscimento e segnalazione della fatica e del sovraccarico;

   c) tecniche di base di facilitazione;

   d) principio di non ritorsione.

   La formazione è svolta da persone con competenze L2 o L3 verificate secondo le norme applicabili.

3. Ogni Assemblea Generale è condotta da due facilitatori, con rotazione obbligatoria. Nella stessa Assemblea non è consentito cumulare la funzione di facilitatore con quella di proponente. Il verbale indica i facilitatori senza riportare dati ulteriori non necessari.

4. Il superamento di uno dei seguenti indicatori attiva un affiancamento organizzativo con il Consiglio di riferimento per la cura:

   a) una media superiore a quindici ore settimanali di attività del Cerchio, calcolata su base trimestrale secondo un metodo aggregato definito dal Consiglio competente;

   b) il superamento dei limiti di picco orario previsti dal Codice 1, articolo 6, comma 5.

   L’affiancamento consiste nella verifica dell’organizzazione e, se necessario, nella proposta di ridistribuzione dei carichi. Non costituisce sanzione, valutazione individuale negativa o limitazione di diritti.

5. La misurazione prevista dal comma 4 è effettuata con criteri aggregati e non può essere utilizzata per classificare le persone o attribuire loro valutazioni individuali. Restano disponibili i canali di segnalazione personale previsti dai Codici applicabili.

6. Può essere promossa, esclusivamente su base volontaria, una procedura di riparazione sociale con una persona di fiducia esterna al Cerchio, scelta di comune accordo. La procedura:

   a) è volontaria per tutte le persone coinvolte;

   b) non è condizione per l’accesso al Codice 4;

c) non ritarda né sostituisce una segnalazione ai sensi dell’articolo 5 del Codice 4;

d) non ritarda né sostituisce il ricorso previsto dall’articolo 17 del Codice 3.

7. Può essere tenuto un registro esclusivamente aggregato e non profilante dei segnali organizzativi di sovraccarico. Il registro è conservato per dodici mesi e consultabile dal Consiglio di riferimento per la cura e dal Consiglio Transizione esclusivamente per le rispettive funzioni, nel rispetto della separazione dei domini prevista dal Codice 6, articolo 11.

8. La documentazione aggregata sull’applicazione del Livello 2 contribuisce alla verifica della soglia F1 → F2 prevista dal Codice 16, articolo 4, comma 2, lettera e).

Art. 4 — Livello 3: autonomia sociale e sicurezza percepita

Fase istituzionale di riferimento: Fase 2 del Codice 16 e, successivamente, mantenimento in Fase 3.

1. Il Livello 3 mira a prevenire la concentrazione relazionale e decisionale, l’endogamia organizzativa e le condizioni che possono compromettere la sicurezza percepita.

2. In ciascun Consiglio non possono operare contemporaneamente più di due persone appartenenti allo stesso nucleo di convivenza stabile. Le informazioni necessarie a verificare tale limite sono trattate in forma riservata e limitate alla finalità di composizione dei Consigli.

3. La rotazione dei Consigli Transizione segue l’articolo 4.4 della Costituzione e l’articolo 5, comma 3, del Codice 16. Si applicano il limite di novanta giorni consecutivi, il limite complessivo di centottanta giorni in trecentosessantacinque giorni e l’intervallo di almeno dodici mesi di attività esclusiva in CBO ordinario tra due mandati, nei limiti previsti dalle norme richiamate.

4. Ogni Cerchio pilota organizza almeno uno scambio inter-Bacino, che comprende la partecipazione volontaria di almeno una persona per una settimana continuativa in un altro Bacino, per attività di contributo. Le spese direttamente necessarie sono coperte dalla Cassa comune secondo le regole applicabili. Il tracciamento dello scambio è aggregato e non profilante.

5. Ogni sei mesi è svolto un questionario anonimo sulla sicurezza percepita, con modalità tecniche idonee a impedire l’identificazione delle persone. La domanda minima è: «Ti senti al sicuro qui?». Le risposte non sono pubblicate quando il numero dei partecipanti non consente un’aggregazione adeguata.

6. Se oltre il venti per cento delle risposte valide è negativo:

   a) la proposta di passaggio alla fase successiva resta sospesa fino alla predisposizione e alla verifica di una misura correttiva;

   b) il Consiglio di riferimento per la cura predispone, entro trenta giorni, un piano rivolto all’organizzazione e alla struttura del Cerchio;

   c) il piano è seguito da una nuova verifica entro sessanta giorni.

   Il superamento della soglia non costituisce, di per sé, motivo di sanzione, esclusione o provvedimento individuale.

7. Un punto di non ritorno ai sensi del Codice 16, articolo 1, comma 2, lettera g), non può essere proposto sulla base esclusiva della valutazione dei componenti interni al Bacino interessato. È richiesto il parere obbligatorio e non vincolante di almeno una persona L3 esterna, sorteggiata secondo la procedura del Codice 4.

8. La documentazione aggregata sull’applicazione del Livello 3 contribuisce alla verifica della soglia F2 → F3 prevista dal Codice 16, articolo 4, comma 3, lettera f), e alla verifica del mantenimento della soglia F3 → F4 prevista dal comma 4, lettera d), del medesimo articolo.

Art. 5 — Documentazione, verifica e aggiornamento

1. La documentazione di ciascun livello è redatta in forma aggregata e non profilante secondo il Codice 7, articolo 2.2. È conservata per trentasei mesi, salvo diverso termine previsto da norma superiore, e resa accessibile secondo l’articolo 15 del Codice 3, nel rispetto della tutela dei dati e della separazione dei

domini.

2. L’applicazione del Protocollo è verificata dal Consiglio Transizione, previo parere obbligatorio del Consiglio di riferimento per la cura.

3. Un parere negativo del Consiglio di riferimento per la cura può sospendere esclusivamente la proposta istituzionale di passaggio di fase fino alla predisposizione e verifica dell’eventuale piano correttivo. Non può comportare sospensioni, esclusioni, sanzioni o limitazioni individuali e non incide sull’accesso al Codice 4, alla Garanzia, ai beni vitali o al Paniere 1-2.

4. L’esito della verifica è trasmesso agli organi competenti secondo l’articolo 4 del Codice 16. Il presente Protocollo non attribuisce al Consiglio Transizione il potere di deliberare autonomamente il passaggio di fase.

5. Il Protocollo può essere aggiornato su proposta del Consiglio Transizione o del Consiglio di riferimento per la cura, secondo l’articolo 19 del Codice 3, previa pubblicazione per almeno settantadue ore. Il Consiglio Transizione non può modificarlo autonomamente né modificare le soglie stabilite dal Codice 16.

6. Nessuna disposizione del presente Protocollo:

    a) introduce competenze permanenti;

    b) modifica le soglie del Codice 16;

    c) introduce obblighi individuali autonomi;

    d) limita diritti o garanzie previsti dai Codici applicabili;

    e) sostituisce i pareri vincolanti previsti dalla normativa di riferimento.

7. **Collegamenti normativi:** Codice 16, articoli 1, 4, 5, 7 e 8; Codice 3, articoli 3, 4, 13–17 e 19; Codice 4; Codice 6, articolo 11; Codice 7, articolo 2.2; Codice 12; Costituzione, articolo 4.